

Fecha Última Actualización: 08-07-2023 4:22:22

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Elizabeth De Las Mercedes Jimenez Tob **Rut** : 14.134.253-3 **N° Archivo** : 0113717 **N° Epicrisis** : 360178
Edad : 42a 3m 19d **Fecha Nacto** : 19/03/1981 **Sexo** : Femenino
Dirección : Pje. Marcela 1834 Villa . Sor Teresa **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 4675 5285

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Intensivo Coronaria **Fecha Ingreso** : 01/06/2023 02:37 **Días Estadía** : 37
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso) **Fecha Egreso** : 08/07/2023 04:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de Conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

- Médicas: Usuaría de válvula protésica mecánica mitral y aórtica(enero/23) anticoagulada. Depresión.

- Quirúrgicos:

---> Drenaje de pielonefritis complicada (2017)

---> RVM + RVAO mecánica (17/01/23).

---> Aseo quirúrgico y hemostasia dado hemotórax bilateral (23/01/23)

--> Aseo quirúrgico por Mediastinitis(31/03/23).

- Fármacos: Acenocumarol, sertralina, risperidona.

-Alergias: No.

- Hábitos: Niega OH, TBQ, drogas.

-Hospitalización:

---> 06/01/23-22/02/23: por endocarditis infecciosa de válvula mitral y aórtica, con insuficiencia severa y reemplazo con válvulas protésicas mecánicas, sin microorganismo aislado. Se complicó con hemotórax bilateral y mediastinitis, este último se identificó S. capitis y C. albicans, completó 6 semanas de terapia antibiótica dirigida, inicialmente cloxacilina + andulafungina, luego rotado a cefadroxilo + fluconazol.

HISTORIA ACTUAL

Consulta por 12 horas de evolución de déficit caracterizado por hemiparesia facio-braquio-crural izquierda, sin fiebre, HGT de ingreso 135mg/dl. NIHSS de ingreso 15, se activa protocolo stroke y se evidenció múltiples infartos pequeños agudos subagudos supratentoriales con componente hemorrágico y oclusión de ACI distal y segmento M1 de la ACM derecha. Además se objetivó, hemorragia subaracnoidea de la convexidad de predominio posterior izquierdo y aneurisma micótico. Destaca al ingreso con INR subterapéutico.

EVOLUCIÓN

Se realizó trombectomía mecánica exitosa con mejoría parcial neurológica. Dado antecedentes se sospechó nuevo episodio de endocarditis, se realizó ETE que confirmó diagnóstico, con vegetación de 17 mm en relación a válvula mitral, complicada con fistulización a la aurícula izquierda y pseudoaneurisma peri aórtico. Se inicio antibioterapia con meropenem + vancomicina. Presentó deterioro neurológico precoz por lo que se excluyó aneurisma con coils (02/06) y luego evoluciona con transformación hemorrágica de ACV y en relación a aneurisma micótico. Sin posibilidad de reiniciar anticoagulación por complicaciones hemorrágicas intracerebrales, sin posibilidad de realizar manejo quirúrgico en pabellón en mismo contexto.

Fecha Epicrisis : 08/07/2023 04:22

Página 1 de 2

Dado mal pronóstico de patología infecciosa cardioquirúrgica con contraindicación de cirugía y complicaciones asociadas a la suspensión de la anticoagulación por válvulas mecánica, se explica a familia y se reorientan los esfuerzos terapéuticos para mantener solamente medidas de confort y favorecer acompañamiento de familiares.

Paciente fallece el 08/07/2023 a las 4:04.

Diagnóstico de Egreso

Endocarditis infecciosa - ACV hemorrágico.

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Enrique Elsaca Merino

Becado/Residente



Camila Daniela Vargas Munoz

Médico Tratante (Staff)